2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ ALAGOAS
Realização
ABEFACC AAMFC

IMPACTOS DO BAIXO ACESSO A MEDICAMENTOS E INSUMOS BÁSICOS EM TERRITÓRIOS RURAIS NO TRATAMENTOS DE DOENÇAS CRÔNICAS

Américo Ferreira Evangelista Neto[1], Reinilson da Silva e Silva[1], Larissa Meira Gomes[1], Daiana Lima Souza[1]
[1]Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Medicamento	Uso terapêutico	Motivo da escassez	Regiões afetadas
Amoxicilina	Antibiótico para infecções bacterianas	Problemas logísticos e distribuição	Norte, Nordeste, Centro-Oeste
Insulina	Tratamento de diabetes	Transporte inadequado e falta de refrigeração	Norte, Nordeste
Propranolol	Tratamento de hipertensão e arritmia	Demanda não prevista e má gestão de estoque	Norte, Nordeste, Sul
Losartana	Controle de pressão arterial	Falta de produção local e altos custos de distribuição	Nordeste, Norte
Dipirona	Analgésico e antitérmico	Falta de planejamento nas unidades de saúde	Norte, Centro-Oeste
Omeprazol	Tratamento de problemas gástricos	Logística onerosa e distribuição irregular	Sul, Nordeste
Cloroquina	Tratamento de malária e doenças autoimunes	Dificuldades de acesso e baixa produção	Norte, Centro-Oeste
Salbutamol (aerossol)	Controle de asma e bronquite	Problemas de transporte e estoque insuficiente	Norte, Centro-Oeste, Sul
Hidroxicloroquina	Tratamento de doenças autoimunes	Escassez devido à alta demanda e problemas logísticos	Norte, Nordeste
Captopril	Tratamento de hipertensão	Falta de distribuição eficiente	Norte, Nordeste, Centro-Oeste

Medicamentos mais escassos em regiões interioranas no Brasil

A escassez de medicamentos em áreas rurais decorre de infraestruturas precárias e de uma lógica de mercado que agrava desigualdades regionais históricas. O desabastecimento de insumos essenciais eleva drasticamente a ocorrência de complicações graves e mortes evitáveis. Esse cenário evidencia que as barreiras logísticas e geográficas comprometem a continuidade terapêutica, exigindo que a Atenção Primária à Saúde implemente estratégias específicas de equidade.

Introdução:

O acesso a medicamentos em territórios rurais é um desafio persistente para o Sistema Único de Saúde (SUS), configurando um grave problema de saúde pública. Barreiras geográficas, escassez de infraestrutura e limitações logísticas dificultam a assistência farmacêutica nessas regiões, impactando diretamente o manejo de condições crônicas. Nesse cenário, as populações rurais enfrentam maior vulnerabilidade, onde a falta de insumos essenciais atua como um determinante para o agravamento de quadros clínicos e a perpetuação de desigualdades regionais no cuidado à saúde.

Objetivos:

Analisar os impactos do baixo acesso a medicamentos e insumos básicos no tratamento de doenças crônicas em territórios rurais brasileiros, considerando barreiras logísticas e socioeconômicas.

Metodologia:

Revisão bibliográfica realizada em bases de dados nacionais e internacionais, com a análise de artigos publicados entre 2010 e 2024, nos idiomas português e inglês, focados em assistência farmacêutica e saúde rural.

Resultado:

A escassez de medicamentos é acentuada por uma lógica mercadológica que prioriza grandes centros urbanos, resultando em disparidades regionais onde o Norte e Nordeste apresentam disponibilidade até 20% inferior ao Sul e Sudeste. A falta recorrente de fármacos essenciais, como insulinas e anti-hipertensivos (losartana e captopril), compromete a continuidade terapêutica de pacientes diabéticos e hipertensos. Esse déficit eleva os riscos de complicações graves, como infartos e AVCs, além de ampliar o índice de mortes evitáveis e o gasto privado das famílias com saúde.

Conclusão:

O baixo acesso farmacêutico rural agrava a vulnerabilidade de pacientes crônicos, demandando políticas de equidade que fortaleçam a Atenção Primária. Garantir o abastecimento regular é essencial para reduzir complicações clínicas e mortes evitáveis, promovendo justiça social e assistência integral nesses territórios.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
AUTOR PRINCIPAL: AMÉRICO FERREIRA EVANGELISTA NETO
GRADUANDO DE ENFERMAGEM
E-mail:202511282@uesb.edu.br